

권고 및 통보

1. 제 목 : 보훈병원 청구 프로세스 및 사업실적·회계처리 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○○○, ○○○○○○

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 「한국보훈복지의료공단법」(이하 “공단법”)에 따라 국가유공자 등에 대한 진료와 중상이자(重傷戾者)에 대한 의학적·정신적 재활 및 직업재활을 지원하여 자립 정착을 도모하고, 복지 증진에 기여하는 것을 목적으로 설립된 기관입니다.

「한국보훈복지의료공단 운영규정 (이하 “운영규정”) 제3조 및 제11조에 따르면 보훈병원의 진료대상자는 국비환자와 사비환자로 구분되며, “보상금”이란 국비환자의 진료비 등을 「국가보훈대상자 의료지원에 관한 규칙」에서 정하는 바에 따라 국가가 부담하는 비용을 말합니다.

일반 의료기관의 진료비 청구 업무는 환자 진료 후 발생한 요양급여비용을 건강보험심사평가원(이하 “심평원”)에 청구하여 심사를 받고, 그 결과에 따라 국민건강보험공단에서 진료비를 지급받는 절차로 이루어집니다.

보훈병원은 이러한 일반 청구 절차 외에 국비환자 진료비에 대한 2차 청구 업무를 추가로 수행합니다. 즉, 1차 청구에 대한 심사결정을 받은 후 보훈병원 의료수가 기준을 적용하여 전체 진료비 총액을 다시 산출하고, 이를 심평원에 2차 심사의뢰(2차 청구)합니다. 이후 확정된 심결통보서를 통해 삭감 금액을 진료수익 및 국비 보상금 정산에 반영하며, 운영규정 제19조에 따라 [표 1]과 같이 처리하고 있습니다.

[표 1] 진료비 청구방법 (운영규정 [별표2])

구 분	청 구 방 법	비 고
국비보험 (급여)	○ 1차 청구 - 건강보험, 의료급여 청구분에 대하여 기존과 동일하게 각 보험자별로 작성하여 청구	현행과 동일, 보험자 부담분 청구
	○ 2차 청구 - 1차 청구분 심사결정 이후 청구 - 보훈병원의료수가기준을 적용하여 청구	국비수가 총진료비 청구
국비일반	○ 2차 청구 - 보훈병원의료수가기준을 적용하여 청구	국비수가 총진료비 청구
감면환자	○ 1차 청구 - 건강보험, 의료급여 청구분에 대하여 기존과 동일하게 각 보험자별로 작성하여 청구	현행과 동일, 보험자 부담분 청구

※ 국비일반 : 무자격자, 상이처

아울러, 보훈병원은 총진료비(EMR 발생액)와 2차 청구액 간의 차이를 국비 정산 진료비 청구차액이라 하여, [표 2]와 같이 ① 청구누락, ② 수입조정, ③ 수입미조정(기타)으로 구분·관리하고 있습니다. 특히 수입조정분의 증감에 따라 매출을 조정하고, 이 내용을 국비 보상금 정산에 반영하고 있습니다.

[표 2] 청구차액 구분 및 회계처리 원칙

청구차액 구분	정의	회계처리 원칙	비고
청구누락	진료월에 수익으로 인식되어 있으나, 청구를 하지 않은 건	조정 대상 아님	심평원에 청구 진행
수입조정 (조정 대상 금액)	자체심사 등으로 확정적으로 받지 못할 금액 등	(+)일 경우 매출 차감 (-)일 경우 매출 증가	
수입미조정(기타) (조정 미대상 금액)	사비→국비 유형변경 등 보훈부로 부터 지원받는 금액 등	조정 대상 아님	

(자료: ○○○○○○ 제공자료 재구성)

한편, 최근 3년간 확인된 1차·2차 청구 관련 주요 오류 사례는 [표 3]과 같습니다.

[표 3] 6개 보훈병원의 청구 관련 주요 오류 사례

구분	오류 유형	사례	결과	비고
○○	엑셀 작업 시 구분코드 착오 입력 (1차 청구)	사비입금 처리 시 수익 인식할 금액(0백만원)과 미수금 차감할 금액(0,000백만원)을 반대로 회계처리	사비 매출액 0,000백만 원 과대 계상	2025년 2월 오류, 2025년 3월 정정
○○	정책지원금 중복 차감 (정책지원금)	정책지원금 포함 청구차액 전체를 매출에서 차감	매출 약 00억 과소 계상 후 '25.7월 재인식	2025년 ○○ 종합감사 시 확인
	매출 인식 시점 오류 (2차 청구)	2차 청구 시점에 청구금액을 매출로 인식 (청구차액 전체를 매출에서 차감 후 2차 청구 시점에 매출 인식)	과거 진료수익 약 0억 원 '25.7월 매출 인식 등	2025년 ○○ 종합감사 시 확인
○○	국사비 전환 오류 등 (1차 청구)	사비→국비 전환 시 매출을 한 번 더 발생, 결손 전 청구누락분 입금금액을 미수금 반제하지 않고 신규 매출 처리 등	0,000백만 원 잡손실 처리	2023년 결산에 손익 반영
○○	수입조정 반대 처리 (2차 청구)	매출 차감해야 할 때 증가, 늘려야 할 때 차감	2017.9월~2025.10월 약 00억 원 매출 과다 계상	2025년 ○○ 종합감사 시 확인
	정책지원금 중복 계상 (정책지원금)	정책지원금 포함 청구차액 전체를 매출에서 증가		2025년 ○○ 종합감사 시 확인

나. 병원별 정책지원금 관련 처리현황

보건복지부는 2024. 2. 20. 전공의 집단행동에 따른 의료공백 방지를 위해 「집단행동 대비 비상진료대책」을 발표하였으며, 이에는 전공의를 대신하여 전문의가 당직근무를 실시할 경우 지원하는 정책지원금이 포함되었습니다.

당초 건강보험 대상에 한정되었으나, 공단 ○○○○○이 2024.3.5. 국가보훈부에 국비환자 동일기준 적용을 요청하였고, 2024.3.7. 국가보훈부가 동일 준용을 회신, 2024.3.12. 이를 6개 보훈병원에 이첩하였습니다.

정책지원금은 1차 청구 시 심평원에 청구·처리되는 금액으로, 2차 청구에서는 발생액 조정 또는 수입미조정으로 관리 하여 매출 조정이 안 되도록 관리하여야 합니다. 다만 업무 매뉴얼·절차서 부재로 병원별 처리 방식이 [표 4]와 같이 상이함을 확인하였습니다.

[표 4] 6개 보훈병원의 정책지원금 관련 2차 청구차액 처리방법

소속기구	2차 청구차액 분류	회계처리	결과	비고
○○보훈병원	발생액에서 제외	-		
○○보훈병원	수익조정분	매출차감	매출과소 (00억 원)	과소 계상된 00억 원 '25.7월 매출 반영
○○보훈병원	수익미조정분	-		
○○보훈병원	수익미조정분	-		
○○보훈병원	수익조정분 및 수익미조정분	추가 매출발생	매출과다 (0.0억 원)	
○○보훈병원	정책지원금 미해당			

(자료: ○○○○○○ 및 6개 보훈병원 제공자료 재구성)

다. 6개 보훈병원 2차 청구 차액 프로세스

6개 보훈병원은 「의료법」 제62조(의료기관 회계기준) 제2항에서 정하는 100병상 이상의 병원급 의료기관으로서, 회계의 투명성을 확보하기 위하여 「의료기관 회계기준」을 준수하여야 합니다.

「의료기관 회계기준 규칙」 제4조(재무제표)에서는 병원의 재무상태와 운영 성과를 나타내기 위하여 재무상태표, 손익계산서, 기본금변동계산서, 현금흐름표를 작성하도록 규정하고 있으며, 제8조(손익계산서)에서 손익계산서는 회계기간에 속하는 모든 수익과 비용을 객관적 자료에 따라 기재하도록 정하고 있습니다.

또한 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」 제4조(회계원칙) 및 공단 「회계규정」 제4조(회계의 원칙)에는 모든 경제적 거래를 발생 시점을 기준으로 복식부기

방식에 따라 회계처리 하도록 규정하고 있으며(발생주의 원칙), 같은 규정 제67조(포괄손익계산서 작성기준)에서는 수익과 비용을 발생한 기간에 정당하게 배분하도록 명시하고 있습니다.

아울러 「의료기관 회계기준 규칙」 제4조(재무제표)에 근거한 「재무제표 세부 작성방법」에는 의료수익을 의료서비스 제공 시점(실현 시기 기준)에 계상하고, 삭감액은 추정하여 반영하지 않으며, 삭감통보로 삭감액이 확정된 경우에 의료미수금과 의료수익을 상계하여 인식하도록 규정하고 있습니다. 따라서 의료수익은 진료가 제공된 시점을 기준으로 인식하여야 하며, 삭감액은 건강보험심사평가원의 통보를 받은 이후 해당 시점에 반영하여야 합니다.

그런데 ○○보훈병원은 2차 청구 시점 매출 인식, 대전보훈병원은 수입조정 반대 처리, 인천보훈병원은 청구차액 분석 미실시 등 병원별 업무 방식이 [표 5]와 같이 상이함을 확인하였습니다.

[표 5] 6개 보훈병원의 2차 청구 프로세스

기본 방식	구분	특이사항	비고
국비 발생액과 청구액 차이에 대한 개인별 세부사유 분석하여 청구누락을 방지하고, 국비정산 관리 기능을 강화 1. 청구누락 2. 수입조정 3. 수입미조정(기타)로 분류하여 국비 발생액(매출액) 조정작업을 함	○○	-	월별 분석결과 보고
	○○	청구차액을 매출에서 선차감, 2차 청구 시 매출 인식 (삭감액, 2차청구분 등 엑셀대장 지속 관리)	의료기관 회계기준 위반 (분석 데이터 검증 용이)
	○○	수익조정분 금액 부분을 +- 반대로 표기하기 위한 작업 진행	-
	○○	-	-
	○○	수입조정분에 대한 결의를 반대로 함	매출 과대·과소 계상
	○○	연중 미실시	연 1회 실시

(자료: 6개 보훈병원 제공자료 재구성)

라. 사업실적 및 운영손익에 대한 영향

공단의 의료사업 실적은 국회·국가보훈부·기획재정부 대외보고 및 이사회·경영평가 등 내부 의사결정의 근거가 됩니다.

그런데 대전보훈병원은 2017년 1월 분석분(회계연월 2017년 9월)부터 수입조정분 반대처리 및 정책지원금 처리 미흡으로 [표 6]과 같이 회계연월 2017년부터 2025년 7월까지 연도별로 매출이 과다 또는 과소 계상되었고,

[표 6] 대전보훈병원 연도별 수익조정 처리 현황 (회계연월: '17.9.~'25.7.)

(단위: 원)

회계연도	올바른 처리금액(정)	실제 처리금액(오)	정정 필요 금액 (정-오)	비고
2017년				매출 과다 계상
2018년				
2019년				
2020년				매출 과소 계상
2021년				
2022년				
2023년				
2024년				매출 과다 계상 (정책지원금 포함)
2025년(~7월)				
합 계				

(자료: 대전보훈병원 제공자료 재구성)

○○보훈병원은 [표 7]과 같이 2020~2024년 발생 의료수익 약 7억 원과 정책지원금 약 00억 원, 합계 약 00억 원을 2025년 7월 매출로 일괄 처리하였고, [표 8]과 같이 사업실적 등에도 반영하여 경영진들에게 왜곡된 경영정보가 제공될 위험이 있었습니다.

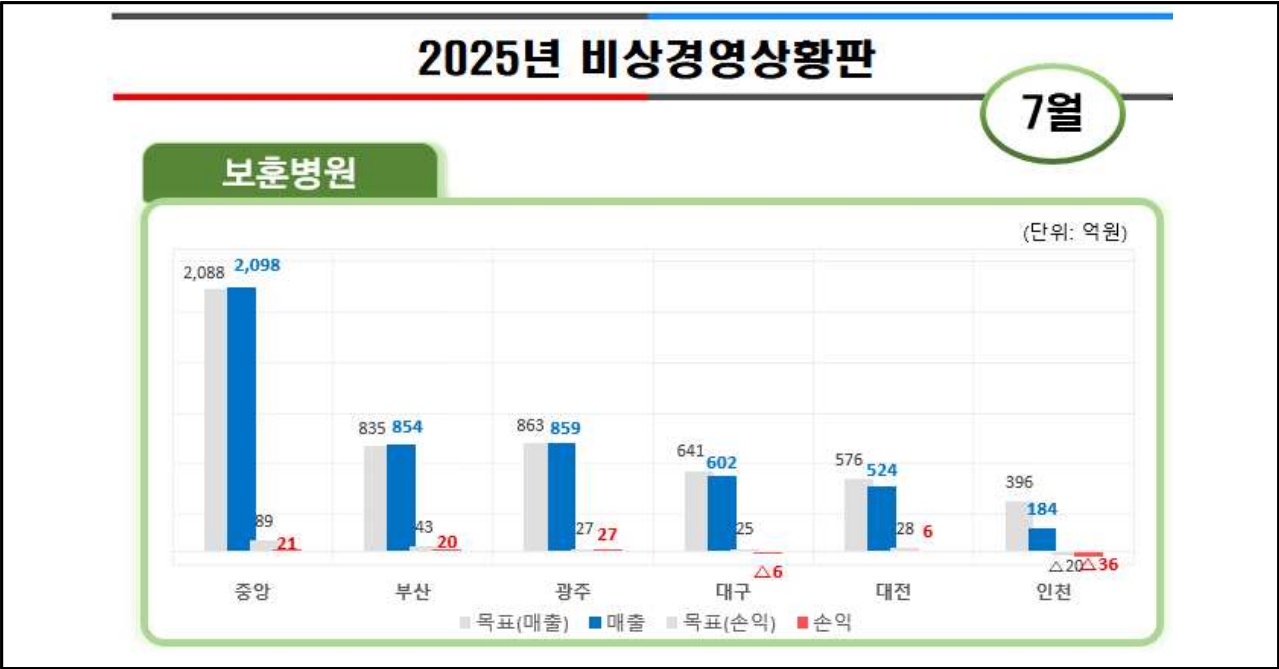
[표 7] ○○보훈병원의 2025년에 수익 인식한 과거 의료매출

(2025.7.31. 기준 / 단위: 천 원)

연도	2025년							진료비 총액
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	
2020년								
2021년								
2022년								
2023년								
2024년								
합 계								

(자료: ○○보훈병원 제공자료 재구성)

[표 8] 2025년 7월 공단 비상경영상황판



(자료: EP 공단경영상황 게시판)

마. 결론

공단의 매출 인식과 관련한 회계처리는 원무과 수납 단계에서 자동 분개가 이루어지기 때문에 오류 가능성이 낮으나, 심사부(보험과)에서 입력하는 수기 전표 과정에서 오류가 반복적으로 발생하고 있습니다. 따라서 수기전표 입력 단계에 대한 내부통제 절차를 강화하고, 궁극적으로는 EMR 및 전산 시스템을 통한 자동화 체계를 구축하여 오류 발생 가능성을 최소화할 필요가 있습니다.

또한 동일한 업무임에도 불구하고 병원별 처리방식과 기준이 상이하며, 사업실적 제출 및 운영손익 반영 과정에서도 차이가 발생하고 있습니다. 그리고 병원 사업실적은 결산에 그대로 반영되어, 사업실적에서 오류가 발생할 경우 결산에도 동일한 오류가 발생하게 됩니다.

우리 공단은 하나의 회계실체로서, 병원별 차별적인 처리 관행은 경영실적의 비교 가능성과 재무정보의 신뢰성을 저해하는 문제를 초래합니다.

따라서 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록, 본사 차원에서 정책지원금 등 정부정책에 대한 회계처리 방식 및 2차 청구차액 처리에 관한 통일된 지침과 매뉴얼을 마련하고, 병원별 청구·정산 데이터에 대한 정기적 검증 절차를 의무화할 필요가 있습니다.

4. 관계기관 의견

○○○○○, ○○○○○에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○이사는

- 청구 및 정산 프로세스의 표준화 지침과 매뉴얼을 제정하고, 병원별 청구·정산 데이터의 정확성과 신뢰성 확보를 위해 정기 검증 및 관련 직원 교육 체계를 구축하시기 바랍니다. (권고)
- 병원 사업실적의 산출 근거(청구·정산 내역)가 결산자료에 정확히 반영될 수 있도록 사업실적 관리 및 검증 절차를 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)

○ ○○안전이사는

- 회계처리에 있어 발생주의 원칙을 철저히 적용하고, 2차 청구차액의 산출 및 회계 반영 기준을 공단 전체에 통일하여 운영할 수 있도록 관리하시기 바랍니다. (통보)